

Summary:

根據病歷資料，陳彥好在 2025 年 5 月至 2026 年 3 月本次入院前的主要病史與治療過程如下：

- **2025 年 5 月 (確診與初步手術)：**於 5 月 21 日針對左前臂腫瘤進行了切片與減積手術 (biopsy and debulking)。
- **2025 年 6 月 (啟動化療計畫)：**自 6 月 2 日起，正式進入「台灣兒童癌症研究群橫紋肌肉瘤高危險群 (TPOG RMS HR) 2016」的治療療程。
- **2025 年 9 月 (癲癇發作)：**於 9 月 12 日突發癲癇（臨床懷疑為 Jeavons 症候群），後續開始規律服用抗癲癇藥物 Levetiracetam。
- **2025 年 10 月至 12 月 (局部放射線治療)：**
 - 左前臂腫瘤原發部位：自 10 月 22 日至 12 月 10 日接受放射線治療，總劑量 5040 cGy，共 28 次。
 - 左腋下淋巴結：自 10 月 22 日至 12 月 3 日接受放射線治療，總劑量 4140 cGy，共 23 次。
- **2026 年 2 月至 3 月 (持續化療與突發惡化)：**
 - 於 2 月 13 日至 14 日期間，接受了療程第 35 週的 VAC (Vincristine, Cyclophosphamide, Dactinomycin) 化學治療。
 - 於 3 月 6 日至 7 日期間，繼續接受了療程第 38 週的 VAC 化學治療。
 - 入院前夕：約在 3 月 20 日（入院前兩天），病患開始出現雙側腰窩疼痛，並於隔日併發下肢麻木與無力。因病情急速惡化，於 3 月 22 日急診就醫，影像顯示 T9 脊椎壓迫性骨折併嚴重脊髓壓迫，隨即收治於小兒加護病房 (PICU)

病患陳彥好的主要診斷與治療過程詳述如下：

一、 主要診斷

1. 左前臂肺泡狀橫紋肌肉瘤 (**Alveolar rhabdomyosarcoma**)：IRS 第 IV 群，TNM 第 4 期，併發多處骨骼與淋巴結疑似轉移（包含 T1、T9、L3 脊椎、右骨盆與左腋下淋巴結）。
2. **T9 脊椎壓迫性骨折併脊髓壓迫**：導致下肢運動神經缺損與麻木，後因腫瘤惡化發展為下半身癱瘓 (Paraplegia)。
3. **其他潛在疾病**：疑似 Jeavons 症候群（有癲癇發作史）、左手下垂（受腫瘤壓迫影響，持續復健中）、以及憂鬱症。

二、 入院原因 (2026/3/22) 病患因雙側腰窩疼痛 2 天，並伴隨下肢麻木與無力（肌力約降至 3/5 級），坐姿時肚臍周圍有壓迫感而就醫。影像檢查顯示 T9 脊椎塌陷及軟組織病灶造成椎管與神經孔嚴重狹窄，引發脊髓壓迫症候群。由於伴隨白血球低下 (1.57 K/uL) 且擔心神經學症狀快速惡化，隨即收治於小兒加護病房 (PICU) 密切觀察並給予類固醇 (Dexamethasone) 治療。

三、 治療過程

- **脊椎減壓手術與術後併發症處理 (3/25 - 4/7)：**病患於 3/25 進行 T9 椎板切除與脊髓減壓手術 (laminectomy and decompression)，術後無力與麻木症狀起初有顯著改善。手術取出的病理組織證實為轉移性肺泡狀橫紋肌肉瘤。術後因短暫低血壓與疼痛，於 3/27 調整鴉片類止痛藥；4/2 轉至普通病房後，出現無力性腸阻塞與神經性腸道問題（持續腹痛與糞便積塞），於 4/6 停用嗎啡並給予腸胃蠕動促進劑後，腹痛才逐漸緩解。4/7 移除中心靜脈導管並順利植入人工血管 (Port-A)。
- **化療重啟與腫瘤急遽惡化 (4/8 - 4/16)：**4/8 重新啟動 VAC 化學治療療程。然而在 4/11 至 4/17 期間，病患面臨嚴重的化療引起之血球低下（血小板曾降至 11K，血紅素降至 7.3），需頻繁輸注紅血球與血小板。不幸地，病患在 4/12 活動後突發下半身癱瘓，4/16 的 MRI 追蹤證實 T9 處的腫瘤範圍變大、疾病惡化。由於腫瘤在全身性治療期間仍快速生長，預後不佳，家屬拒絕進一步接受手術，醫療團隊於 4/13 針對 T9 等部位啟動姑息性放射線治療以控制症狀。
- **骨髓抑制、感染與標靶治療介入 (4/17 - 4/27)：**4/17 因極度嗜中性白血球低下（WBC 於 4/20 降至 0.31K）併發發燒，團隊開始投予抗生素 (Tazocin) 與白血球生長激素 (G-CSF)，所幸血液與尿液培養結果均為陰性。期間放射線治療因嚴重血球低下短暫暫停，待 4/22 血球回升後恢復進行。4/22 的次世代基因定序 (NGS) 結果顯示帶有 PIK3CA H1047R 突變，在家屬同意下，於 4/24 起加入口服標靶藥物 Everolimus 與 Alpelisib 交替治療。針對後續出現的嚴重肋骨痛與喉嚨痛，團隊亦加入了神經痛藥物 Gabapentin 及局部喉嚨噴劑來加以緩解。

四、出院前現況 截至 2026/4/27，病患血行動力學穩定，正從化療引起的骨髓抑制期中逐漸恢復，目前下肢依然維持癱瘓狀態，臨床上持續進行安寧放射治療、標靶治療與症狀控制。因家屬居住考量，後續希望能轉回台南當地進行照護